

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 22/02/2026 12:15

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Glicemia

DESCRIÇÃO:

njmk

RESULTADO:

****Relatório de Análise Médica****

****Nome do Paciente:**** xavier Tchivela

****Idade:**** 24 anos

****Gênero:**** Masculino

****Tipo de Exame Informado:**** Glicemia (Nota: Inconsistente com a imagem fornecida, que é uma microscopia de sedimento urinário.)

****Urgência Informada:**** NORMAL

****1. Descrição da Imagem e Qualidade Técnica****

A imagem apresentada corresponde a um campo microscópico de sedimento urinário, capturado com boa qualidade técnica. O foco é nítido, a iluminação é adequada e a magnificação utilizada parece ser apropriada para a identificação de elementos figurados na urina (provavelmente campo de grande aumento - CGA). Há uma homogeneidade na distribuição dos elementos visíveis. É importante salientar que, apesar de o contexto clínico indicar "Glicemia" como tipo de exame, a imagem é claramente uma análise microscópica de urina.

****2. Achados Principais****

A análise microscópica revela:

* ****Cristais de Fosfato Triplo (Estruvita):**** Presença abundante de cristais característicos de fosfato triplo (fosfato amônio-magnésiano), que se apresentam predominantemente com morfologia retangular, prismática, frequentemente descritos como "tampas de caixa". Estes cristais são proeminentes em todo o campo visual.

* ****Outras Partículas:**** Observam-se também inúmeras partículas menores e arredondadas, que podem ser hemácias, pequenas células epiteliais ou debris amorfos, mas em menor destaque e quantidade comparadas aos cristais de fosfato triplo.

****3. Diagnóstico Sugerido****

Com base na análise da imagem:

* ****Cristalúria por Fosfato Triplo (Estruvita) Massiva:**** A presença em grande quantidade desses cristais é o achado mais significativo.

* ****Considerações Etiológicas:**** Cristais de fosfato triplo são tipicamente encontrados em urina alcalina e são fortemente associados a Infecções do Trato Urinário (ITUs) causadas por bactérias produtoras de urease (por exemplo, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*). E...

[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

* ****Urocultura com Antibiógrama:**** ESSENCIAL. Coletar amostra de urina de jato médio para cultura e antibiógrama. Este exame é crucial para identificar a bactéria responsável pela infecção e determinar quais antibióticos serão eficazes para o tratamento.

3. **Avaliação Clínica Abrangente:**

* O tratamento da infecção subjacente (se confirmada) geralmente auxilia na normalização do pH urinário. Qualquer intervenção para acidificação urinária deve ser avaliada e monitorada por um especialista (urologista/nefrologista) após a identificação da causa e, preferencialmente, após o tratamento da infecção.

6. **Sinais de Alerta para Retorno Imediato:**

* Procurar atendimento médico de urgência em caso de: febre alta, calafrios, dor lombar intensa e súbita, sangramento urinário visível (hematúria macroscópica), dificuldade ou incapacidade de urinar,

ou piora dos sintomas gerais.

7. ****Data para Retorno:****

* Agendar retorno com o médico clínico geral ou urologista após a realização de todos os exames complementares solicitados (Uroanálise, Urocultura e exames de imagem) para avaliação dos resultados e definição do plano terapêutico.

RECOMENDAÇÕES

****RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS:****

1. ****Confirmação e Esclarecimento do Exame:****

* Verificar e confirmar o tipo de exame realizado, ratificando a interpretação como análise de sedimento urinário.

2. ****Exames Complementares Urgentes:****

* ****Uroanálise Completa (Sumário de Urina):**** Realizar com máxima brevidade. Avaliar parâmetros como pH urinário (atenção a valores > 7.0), densidade, presença e quantidade de leucócitos, eritrócitos, nitritos e proteínas, que podem reforçar a suspeita de ITU.

****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:****

* A presença massiva de cristais de estruvita é um achado clinicamente significativo que requer investigação ativa para identificar e tratar uma possível infecção urinária por microrganismos produtores de urease, a fim de prevenir complicações como a formação de cálculos renais obstrutivos e recorrentes.

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: sfgh

radiologista

Receita gerada em 22/02/2026 12:15

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica